

Первичная и вторичная профилактика – реальный путь к снижению заболеваемости и смертности от рака в Республике Казахстан

Монахов Б.В.

Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова

Актуальность

В Республике Казахстан ежегодно выявляется почти 30 000 больных со злокачественными новообразованиями, около 110 тысяч больных находится под наблюдением областных и городских онкологических диспансеров.

Среди впервые выявленных больных в 31% случаев установлен своевременный диагноз (I-II стадии заболевания), когда шансы на излечение вполне удовлетворительны; у 69% больных обнаруживаются распространенные формы злокачественных новообразований, когда радикальное лечение можно провести только у 2-4 из 10 больных. В целом пятилетняя выживаемость онкологических больных не превышает 50%, причем этот показатель за последние 10 лет, несмотря на многосторонние комплексные попытки увеличить выживаемость этих больных, не меняется. Следует заметить, что около 2/3 онкологических больных становятся инвалидами I и II групп, находясь в трудоспособном возрасте.

Особо следует обратить внимание на постоянно растущую стоимость методов комплексного лечения онкологических больных. Так, один курс современной химиотерапии рака молочной железы может составить до 2000 и более долларов США, в то время же рекомендуется проводить 4-5 таких курсов. Такую же сумму составляет современная химиотерапия рака молочной железы, желудка, толстой кишки и других локализаций. Хирургическое и лучевое лечение злокачественных новообразований составляет почти такой же экономический уровень. Естественно никакие финансовые вложения государства и подавляющее число онкологических больных не смогут компенсировать такие баснословные суммы.

В течение 10 лет сохраняется высокая смертность от злокачественных новообразований, и никакие современные достижения в их лечении не оказывают влияния на снижение общей летальности. Например, летальность на 1 году с момента установления онкологического заболевания составляет 35%. Учитывая сложившуюся онкологическую ситуацию в Республике, достоверные современные методы снижения риска заболевания более чем на 70%, а также накопленный ранее положительный казахстанский опыт, в отношении которого наше государство по инициативе основателя онкологической службы Республики профессора С.Н.Нугманова было одним из лидирующих в мире, предлагается современный комплекс мероприятий по первичной и вторичной профилактике основных наиболее распространенных локализаций злокачественных новообразований.

Научная основа профилактики рака

Научной основой профилактики рака служат современные знания механизмов канцерогенеза, обобщающий опыт многочисленных экспериментальных и эпидемиологических исследований, достоверно указывающий на существование прямой связи между воздействием внешних агентов, эндогенных метаболитов и развитием под их влиянием опухоли с определенным латентным периодом.

Исходя из общего вклада отдельных факторов риска и путей их воздействия, имеются основания полагать, что с

помощью целенаправленных санитарно-гигиенических и биохимических мер, создания оптимальных условий для течения физиологических процессов в организме человека, активного выявления и лечения предопухолевых заболеваний можно не только снизить риск возникновения злокачественных новообразований, но и уменьшить их частоту, увеличить процент выявления ранних стадий рака и снизить его общую смертность.

Основные формы профилактики рака

В настоящее время выделяются следующие виды профилактики рака:

- первичная (гигиеническая) профилактика злокачественных новообразований;
- вторичная (клиническая) профилактика;
- противораковая борьба;
- массовый скрининг населения или целевых групп для выявления онкопатологии.

Первичная профилактика рака

Первичная профилактика рака направлена на устранение или снижение воздействия канцерогенных (химических, физических и биологических) факторов на клетки-мишени, повышение специфической и неспецифической сопротивляемости организма; определенный эффект при этом имеют адаптогены, обладающие поливалентной активностью и значительной терапевтической широтой. Первичная профилактика рака осуществляется с помощью санитарно-гигиенических мероприятий, а также путем коррекции биохимических, генетических, иммунобиологических и возрастных нарушений у человека.

Представляется, что более надежный путь профилактики – полное устранение воздействия канцерогенных факторов. Однако там, где невозможно устранение, в частности на промышленных предприятиях и зонах движения автомобильного транспорта и повышенной радиоактивности, требуется гигиеническое регламентирование и соблюдение безопасных или предельно допустимых доз и концентраций канцерогенов путем установления ПДД и ПДК. Поэтому во многих экономически развитых странах первичная профилактика злокачественных новообразований завоевывает все большую популярность, приоритетное значение в проведении которой принадлежит самому человеку.

Питание

Продукты питания, их качество и сбалансированность, отсутствие канцерогеносодержащих веществ – главные составляющие предупреждения рака не только органов пищеварения, но и молочной железы, тела матки и других систем и органов. Путей для реализации этого направления несколько. Не претендуя на полноту, остановимся лишь на некоторых из них. Чрезмерное в калорийном отношении питание и ожирение способствует возникновению опухолей различных локализаций. Ожирение, как один из компонентов нарушения обмена веществ, в сочетании с диабетом и нарушением процессов

обратной связи между гипоталамусом, гонадотропными гормонами и инсулином – отражение общих механизмов канцерогенеза. Гормоны и холестерин могут играть двойную роль: стимулировать опухолевый рост или самостоятельно становиться активными канцерогенами, особенно если они присутствуют в избытке. По своей структуре они близки к полициклическим канцерогенам, разница лишь в радикалах. Уменьшение потребления животных жиров ниже 30% ведет к снижению уровня холестерина и эстрогенов.

Полнота (избыточная масса тела) признана фактором риска для здоровья в целом, полные люди подвергаются большему риску заболевания раком молочной железы, толстой кишки, предстательной железы, тела матки, поджелудочной железы и др. При оценке обычно имеют в виду полноту, превышающую 20% в соотношении роста и веса. Однако одно питание с низким содержанием жиров проблемы рака не решает. Как оказалось, для снижения риска онкологических заболеваний одновременно необходимо повышение потребления фруктов и овощей, богатых содержанием витаминов, минеральных веществ, клетчатки и множества уникальных биохимических веществ.

Важность свежей растительной пищи связана с содержанием биофлавоноидов и волокнистой нерастворимой клетчатки, способной подавлять ферменты, нейтрализовать эстрогены, абсорбировать и обезвреживать канцерогенные агенты, которые могут попадать в кишечник с продуктами питания. Эксперты США по профилактической медицине рекомендуют фрукты и овощи 5 раз в день для укрепления здоровья. Большое значение в химиопрофилактике рака придается витаминам А, С и группы В. Витамин А и каротиноиды препятствуют накоплению канцерогенов в организме и уменьшают их воздействие на клетки. Они предупреждают развитие рака пищевода, желудка, легкого, мочевого пузыря, предстательной железы и толстой кишки. Бета-каротин эффективен в предупреждении спонтанного, химического и радиационного канцерогенеза, препятствует развитию опухолей кожи, индуцированных ультрафиолетовой инсоляцией.

Витамин С в больших дозах (до 10 г и более) рассматривается как антиоксидант и иммуномодулятор, однако введение витамина С в чистом виде и больших дозах чревато аллергическими реакциями. Более полезным является потребление продуктов с высоким содержанием витамина С, таких как шиповник, смородина, красный и зеленый перец, петрушка, укроп, рябина, цитрусовые и др.

Важную роль в профилактике анемий и опухолей желудочно-кишечного тракта играют продукты, богатые грубой клетчаткой и витаминами группы В. Волокнистая растительная пища является стимулятором моторики кишечника, инактиватором и естественным адсорбентом метаболитов желчных кислот, эстрогенов, канцерогенов, поступающих извне (экзогенных) и образующихся в организме (эндогенных). К таким растительным продуктам относят зерновые (пшеница, кукуруза. Гречиха, рожь, овес, ячмень, рис) и бобовые культуры (фасоль, зеленый горошек) – цельные, грубого помола в виде отрубей или проросших молодых побегов. Необходимыми компонентами предупреждения злокачественных опухолей являются микроэлементы. Важная роль принадлежит селену и кальцию, недостаток которых ведет к увеличению частоты рака и активации процессов метастазирования.

К числу профилактических мер питания является использование экологически чистых продуктов, ограничение жареной пищи, маринадов и копченостей. Следует исключить прием слишком горячей пищи и повторное применение жиров в кулинарии. Пищевой рацион должен быть разнообразным и многокомпонентным.

Десятки эпидемиологических исследований показали снижение риска рака толстой кишки у людей длительно принимавших ацетилсалициловую кислоту и другие нестероидные противовоспалительные средства. Такая же закономерность

была установлена в отношении рака желудка и нижней трети пищевода. Клинико-биохимические разработки показали, что нестероидные противовоспалительные средства ингибируют циклооксигеназную активность, приводят регрессии полипов, уменьшают их рост у больных семейным полипозом толстой кишки. Правда, у больных аденоматозными полипами применение нестероидных противовоспалительных средств менее эффективно.

Обширные рандомизированные исследования подтвердили эффективность тамоксифена для профилактики рака молочной железы. У женщин, получавших тамоксифен, заболеваемость раком молочной железы была снижена на 38%, а у женщин, принимавших ралоксифен заболеваемость была снижена на 64% по сравнению с контрольной группой. Однако тамоксифен имеет побочных эффект в виде развития гиперплазий эндометрия и повышенной частоты тромбозов. Поэтому в настоящее время для тех же целей рекомендуется применение ингибиторов ароматазы (фемара, аримидекс и др.).

Гигиена дыхания

Наиболее опасным и значимым фактором в развитии рака органов дыхания, полости рта, пищевода, желудка, поджелудочной железы, мочевого пузыря и других органов является табакокурение. Доказано, что и некурящий человек, постоянно пребывающий в прокуренном помещении, также подвержен заболеванию раком легкого, как и курящий.

Установлено, что в табачном дыме содержатся полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) – бензпирен, ароматические амины и нитрозамины, а также радий, торий, полоний и радиоактивный свинец. Наряду с этим, в табачном дыме имеются коканцерогены, эфирные масла, которые усиливают эффект истинных канцерогенов. В этой связи отказ от курения является оптимальным средством индивидуальной профилактики рака легких. Другой не менее важной задачей является борьба за чистоту атмосферного воздуха, которая приобретает особое значение для работающих с производственными вредностями и жителей промышленных городов. Профилактическими мерами являются установление улавливающих фильтров, создание замкнутых технологий, расширение зон зеленых насаждений.

Физическая активность

Человек, вынужденный находиться в сидячем или ном малоподвижном положении более 4-5 часов в день, имеет высокий риск развития застойных явлений во всех частях тела и внутренних органах (снижен лимфо- и кровоток). По данным экспертов ВОЗ, малоподвижный образ жизни отрицательно сказывается на функции лимфоцитов, что проявляется в угнетении иммунных реакций, гипоксии, гиповентиляции и нарушении дренажной функции легких, увеличении экспозиции воздействия канцерогенных факторов. При сравнении групп людей с высокой и низкой физической активностью было выявлено, что уровень заболеваемости злокачественными опухолями на 60–70 % ниже в первой группе. Ценность физических занятий особенно очевидна, когда они проводятся регулярно.

Клиническая (вторичная) профилактика рака

Клиническая профилактика рака включает в себя выявление, лечение и наблюдение лиц, уже имеющих хронические или предраковые (факультативные и облигатные) заболевания, а также контингентов людей, подвергавшихся или подвергающихся инфицированию онкогенными вирусами, определенному воздействию канцерогенных факторов и нуждающихся в хирургической, лекарственной или иной коррекции и динамическом наблюдении. Эффективность такой профилактики несо-

мненна, хотя далеко не одинакова при разных локализациях. Благодаря выявлению предраковых заболеваний на уровне смотровых кабинетов и последующему их лечению почти во всех регионах Казахстана наметилась четкая тенденция к снижению заболеваемости раком шейки матки. Такая же закономерность обнаружена в регионах Казахстана с высокой заболеваемостью раком пищевода, где получили широкое распространение активное выявление, лечение и диспансеризация рефлюкс-эзофагитов.

Учитывая накопленный положительный опыт казахстанскими специалистами, новые мировые достижения возможностей эффективного лечения факультативных форм предопухолевых заболеваний, мы считаем целесообразным расширить и усовершенствовать разработанную ранее нами методику клинической профилактики рака наиболее распространенных форм злокачественных новообразований в Казахстане. Однако в зависимости от локализации злокачественного процесса методы его профилактики, а именно: диагностика предопухолевых заболеваний и их лечения будут принципиально отличаться друг от друга. Как показывают статистические показатели, среди почти 30000 впервые выявленных онкологических больных, которые регистрируются ежегодно, почти 14500 заболевают раком пищевода, желудка, ободочной и прямой кишок, легкого, и молочной железы. В соответствии с современным уровнем онкологической науки возникновение каждого из этих онкологических заболеваний может быть предупреждено или заторможено путем активного выявления и лечения предопухолевых его заболеваний. В связи с принципиальными особенностями методов диагностики и лечения предрака необходимо привести эти мероприятия в соответствии с каждой локализацией.

Рак легкого занимает лидирующее положение в структуре злокачественных опухолей. Ежегодно диагностируется почти 4 тысяч больных. Причем эта патология участвовала в 7 областях и г. Алматы. Максимальные показатели отмечены в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях. Причем в 7 из 15 регионов 30% и более больных раком легкого регистрируется в IY стадии заболевания.

Современная профилактика рака легкого может быть осуществлена в трех направлениях:

В эпидемиологически неблагоприятных областях должна быть сосредоточена вся работа по ранней современной массовой диагностике и активному лечению хронических obstructивных бронхитов как факультативного предрака.

Особое внимание следует обратить работников регионов независимо от занимаемой должности борьбе с курением. Эксперты ВОЗ сделали вывод на основании многолетних исследований почти во всех странах мира следующего содержания: «Если бы удалось положить конец курению сигарет, то это дало бы намного больше для улучшения состояния здоровья населения и увеличения продолжительности жизни, чем любая иная акция клинической медицины».

Работникам промышленных предприятий с повышенной канцерогенностью и радиоактивностью, работникам автомобильного транспорта следует рекомендовать прием антибластомогенных средств, антиоксидантов и др., которые снижают риск появления раков легкого.

В указанных областях должно быть достаточное количество рентгенодиагностической и фибробронхоскопической аппаратуры.

Рак желудка по заболеваемости и смертности занимает второе место в РК, ежегодно им заболевают почти 3 тысячи человек, из них 84.6% умирают. Более всего это заболевание распространено среди жителей г. Алматы, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской, Кызыл-Ординской, Костанайской, Западно-Казахстанской областей. Причем в этих областях почти половина больных диагностируется на IV стадии заболевания, что свидетельствует об отсутствии онкологической настороженности врачей общей лечебной сети и соответствующей корректирующей работы со

стороны онкологической службы. В то же время опыт казахстанских онкологов 70-80 годов XX века показал, что ситуацию по раку желудка можно контролировать путем активной диспансеризации больных факультативными предопухолевыми заболеваниями и проведения им полноценной консервативной терапии, что позволило снизить частоту малигнизации предрака, повысить работоспособность больных предопухолевыми заболеваниями и увеличить частоту диагностики ранних форм рака желудка.

Современная профилактика рака желудка может осуществляться следующими путями:

Массовое проведение гастродиброскопии с прицельной биопсией лицам старше 40 лет с целью выявления субклинических и клинических форм предопухолевых и опухолевых заболеваний и ранних форм рака желудка.

Выявленные облигатные (полипы и др.) формы предраковых заболеваний следует подвергнуть хирургическому лечению и последующему наблюдению в течение 2 лет, что обеспечит полное оздоровление больных этой категории.

Выявленные факультативные (различные формы хронических гастритов, язвы желудка) формы предраковых заболеваний, верифицированные морфологически, должны быть активно подвергнуты полноценной лекарственной терапии с обязательным эндоскопическим контролем каждые 3-6 месяцев в течение 3-5 лет.

Очевидна экономическая эффективность представленных мероприятий, состоящая в оздоровлении больных предраком, повышении их трудоспособности и сокращении длительности пребывания их на больничном листе.

Рак молочной железы занимает первое место в структуре заболеваемости и смертности злокачественных опухолей у женщин. Ежегодно более 3 тысяч женщин заболевают раком молочной железы, при этом у каждой пятой женщине обнаруживается IV стадия рака молочной железы, что свидетельствует о том, что казахстанские женщины недостаточно пользуются методами самообследования молочных желез. Благодаря усилиям Министерства здравоохранения РК в 2005 г. создана единая система маммографического обследования молочных желез. Однако лечение предопухолевых заболеваний молочных желез носит хаотичный, порою мало профессиональный характер. Ни в одной из областей Республики никогда не ставился вопрос о возможности профилактики рака молочных желез путем активного лечения факультативных и облигатных форм предопухолевых заболеваний. Причем такая ситуация сложилась на фоне неуклонного роста заболеваемости рака молочной железы, темпы прироста которого составляют ежегодно 14-15%. В то же время опыт зарубежных специалистов свидетельствует о радикальных возможностях изменения такой ситуации путем экономичных, эффективных и доступных в массовом масштабе методов ранней диагностики и лечения факультативных и облигатных форм предопухолевых заболеваний, что может в 2-3 раза предупредить развитие рака молочной железы и тем самым снизить частоту его развития в Республике. Имеющиеся современные методы позволяют рекомендовать их использование у населения РК.

При этом возможны следующие пути профилактики рака молочной железы в Республике Казахстан:

Обязательное обучение всех женщин, начиная со школьного возраста, методам регулярного самообследования молочных желез.

Повсеместное проведение регулярных (каждые 2-3 года) маммографических обследований молочных желез с целью раннего выявления факультативных и облигатных форм предопухолевых заболеваний и субклинических форм рака молочной железы.

При наличии факультативных форм предопухолевых заболеваний (диффузные мастопатии) у женщин старше 40 лет следует рекомендовать прием тамоксифена (нольвадекса) по 10 мг через день в течение не менее 2-2.5 лет, что, как

достоверно доказано, в 2-3 раза снизит риск развития рака молочной железы у этих женщин. Согласно новым сведениям более выраженной профилактической активностью обладают ингибиторы ароматазы (фемара и др.).

Широкое использование малых доз тамоксифена, не вызывающих гиперплазий эндометрия, у молодых женщин при наличии масталгий, которые купируются данным препаратом у 90-95% больных.

Рак ободочной и прямой кишок регистрируется в Казахстане ежегодно более чем у 2 тысяч больных, иначе говоря, у каждого 11-12 больного злокачественным новообразованием. Чаще всего раком толстой кишки болевают жители г. Алматы, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областей. Более чем 40% больных раком толстой кишки умирают в течение 1 года после выявления заболевания, что свидетельствует о поздней диагностике этого процесса. В Казахстане никогда не использовался такой простой метод скрининга как определение гемокультеста, простого, экономичного и эффективного. Пальцевое исследование прямой кишки в условиях профилактического обследования делается крайне редко.

Принципиально новым достижением в области клинической профилактики рака толстой кишки являются утверждения американских, немецких, голландских онкологов о целесообразности массового применения ацетилсалициловой кислоты 0.3 г ежедневно длительно, что существенно снижает риск возникновения рака толстой кишки. Эта рекомендация, вероятно, носит в какой-то мере универсальный характер, если учесть профилактический эффект аспирина в развитии тромбозов, инфарктов миокарда, атеросклеротических изменений у людей старше 40 лет, когда вероятность рака толстой кишки носит нарастающий характер. Поэтому массовая «аспиринизация» населения носит популяционную направленность и в предлагаемой дозе не имеет каких-либо побочных реакций.

В связи с изложенными материалами современная профилактика рака толстой кишки может включать следующие компоненты, осуществление которых отличается доступностью и экономичностью:

Обязательное ознакомление населения с особенностями питания, поведения и отношения к хроническим заболеваниям толстой кишки как фактора риска рака толстой кишки.

Проведение массовых определений (3-4 раза в год) скрытой крови в кале у населения старше 40 лет с целью выявления группы риска и последующей проведения у таких больных ирригоскопии и колоноскопии с последующей прицельной биопсией для морфологического исследования.

Рекомендация массового приема 0.3 г аспирина людям старше 40 лет ежедневно в течение ряда лет как профилактического средства с целью снижения риска рака толстой кишки, инфаркта миокарда, инсульта головного мозга, тромбозов, атеросклероза сосудов.

Рак пищевода регистрируется ежегодно почти у 1.5 тысяч человек, занимая 5-е место. Наибольшая частота данной патологии, в 2-3 раза большая, чем в среднем по Республике отмечена в Кызылординской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях. За последние 5 лет наметился годовой прирост заболеваемости, в то время как в 80-90 годы XX века имело место значительное его снижение. В 60-е годы рак пищевода в Казахстане был социальным бедствием. Начатая в конце 1960-х годов и проводимая в 1970-80-е годы активное выявление и лечение предопухолевых заболеваний пищевода привело к снижению заболеваемости раком пищевода в Казахстане. Однако эта работа в 90-е годы была полностью прекращена и настоящий подъем заболеваемости является следствием приостановления этой важной и эффективной работы.

Кстати сказать, параллельно подъему заболеваемости раком пищевода в настоящее время в РК наблюдается увеличение частоты рака желудка, так как предопухолевые заболевания этих органов развиваются неразрывно друг от

друга; их лечение также осуществляется в одном патогенетическом цикле и в конечном итоге ведет в той или иной мере к торможению прогрессирования патологических процессов в слизистой оболочке обоих органов, препятствуя ее малигнизации. Приведенные выше сведения обосновывают целесообразность возобновления ранее проводимой и плодотворной работы по профилактике рака пищевода, которая может быть осуществлена в следующих направлениях:

Широкое использование функционального теста на рефлюкс-эзофагит (кисотно-перфузионный тест в нашей (автор – профессор Б.В.Монахов) модификации), позволяющий оценить барьерную функцию слизистой оболочки пищевода, которая тесно взаимосвязана с морфологическими изменениями в ней.

Массовое использование фиброскопического исследования пищевода и желудка с последующим морфологическим изучением слизистой оболочки этих органов.

Активное лечение субклинических и клинических форм предопухолевых заболеваний пищевода и желудка и обязательная диспансеризация этих больных с целью контроля динамики изменений эпителия этих органов, проведения противорецидивных курсов лечения и ранней диагностики возможной малигнизации.

Противораковая пропаганда и ее уровень определяет в значительной мере эффективность самой профилактики. Разъяснительная работа начинается задолго до медицинских осмотров и продолжается в процессе их с использованием всех каналов и форм массовой и индивидуальной информации.

Противораковая пропаганда среди населения ставит своей целью:

- ознакомление населения с первыми сигнальными признаками рака;
- убеждение в необходимости регулярных медицинских обследований;
- воспитание привычки социально следить за состоянием своего здоровья, обучение методам самообследования полости рта, молочных желез, кожи и др.;
- вселение уверенности в успех излечения при своевременном выявлении раков;
- пропаганда здорового образа жизни, санитарно-гигиенических знаний, являющихся основой первичной профилактики рака;
- убеждение в активном выявлении и эффективном лечении предопухолевых заболеваний, обеспечивающих непосредственное оздоровление организма в целом и снижающих риск малигнизации в том или ином органе.

Скрининг-тесты

Согласно докладу экспертов ВОЗ по раннему выявлению рака, скрининг-тесты для выявления злокачественных новообразований должны характеризоваться следующими признаками:

- простота и легкость и быстрота выполнения теста с минимумом дискомфорта;
- чувствительностью и надежностью – пригодность теста для диагностики ранних стадий рака и низкий процент ложноотрицательных и ложноположительных результатов;
- продуктивность – высокая частота выявленных больных предраком и раком;
- экономичность – низкая стоимость использованного оборудования и необходимых реактивов.

Учитывая изложенные требования, массовое обследование населения может включать использование таких тестов и методов:

1. анкетный метод.
2. флюорографический.
3. маммографический.
4. цитологический.

5. иммунологический.
6. генетический.
7. биофизический.
8. микологический.
9. иммуно-флюоресцентный.
10. радиоиммунный.

Региональные структуры как координаторы в реализации программы комплексной профилактики рака

Комплексная первичная и вторичная профилактика рака может быть осуществлена с помощью специальных подразделений, координирующих все перечисленные выше формы предупреждения злокачественных новообразований. Главным координатором реализации этих мероприятий может быть Департамент по лечебно-профилактической работе, аккредитации и анализа Министерства здравоохранения РК, который может проконтролировать осуществление каждого этапа санитарно-гигиенического, организационного, общего лечебного и онкологического звеньев в РК в целом и в ее регионах. Вероятно,

будет целесообразным организовать 5 межрегиональных центров по первичной и вторичной профилактике рака на западе, юге, севере, востоке и в центре Республики, в структуру которых будут входить отделы по комплексной профилактике рака. Каждый такой межрегиональный центр должен включать локальные самостоятельные отделения профилактики рака, осуществляющих всю работу на уровне населения областных, городских и районных акиматов.

Таким образом, изложенные сведения свидетельствуют о реальном их осуществлении, с одной стороны, и возможности существенного влияния комплексных профилактических мероприятий на имеющуюся в РК онкологическую ситуацию, с другой. Предлагаемые комплексные материалы в значительной мере согласуются с перспективным Планом мероприятий по реализации Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан годы и соответствующими директивами Министерства здравоохранения РК (приказ № 14 от 11.01.05 и приказ № 114 от 15.03.05), которые указывают на необходимость научно-методического обеспечения и мониторинга ежегодных профилактических осмотров, диспансеризации и оздоровления населения.

Заболеваемость раком прямой кишки населения Республики Казахстан за 2000-2009 годы

*Кузикеев М.А., Сейтказина Г.Д.
Казахский НИИ онкологии и радиологии
УДК: 616.351-006.6 -036.22 (574)*

Актуальность

За последние десятилетия значительно увеличилась заболеваемость раком прямой кишки и авторы связывают это с некоторыми факторами, такими как изменением питания людей, большим количеством канцерогенов, увеличением продолжительности жизни.

Большинство авторов определяет его как умеренно- или малоподвижную опухоль, ограниченную мезоректомой или выходящую за пределы фасции прямой кишки, с прорастанием в соседние органы или отсутствие отдаленных метастазов. Высокая частота рецидивирования этой формы опухоли (26-37%) и низкая 5-летняя выживаемость (38-52%) характерны для данной локализации (Александров В.Б., 2001; Кныш В.И., 1997).

Рак прямой кишки занимает 6-е место в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями в России. При этом местнораспространенный рак прямой кишки составляет до 20-30% (Чиссов В.И. и соавт., 2006).

Онкологическая статистика является основой как организации и проведения противораковой борьбы, так и научных исследований в онкологии. Частота злокачественных новообразований по отдельным нозологическим формам не осталась величиной постоянной. Кроме того существуют значительные различия в числе случаев заболеваний раком прямой кишки между мужчинами и женщинами, городских и сельских жителей.

Знание всех этих особенностей позволяет не только рационально проводить нынешние мероприятия противораковой борьбы, но и с учетом изменяющейся (в сторону постарения населения) демографической ситуации.

Настоящая статья посвящена анализу структуры и временных особенностей распространения рака прямой кишки среди населения Республики Казахстан за период 2000-2009 гг.

Цель исследования

– изучить особенности заболеваемости раком прямой кишки населения Республика Казахстан.

Материал и методы исследования

Исследование ретроспективное за 2000-2009 гг. Использованы данные показателей онкологической службы РК (Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д., Игисинов С.И. и др., 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010).

За этот период исследования в республике зарегистрировано 11098 больных раком прямой кишки, что составляет в структуре злокачественных опухолей – 4,0%.

Анализ среднегодовых интенсивных показателей заболеваемости рака прямой кишки в республике в возрастных группах в динамике за изучаемый период показал, что данные показатели имели тенденцию к росту. Так, среди лиц 0-29 лет данные показатели, как у мужчин, так и у женщин (0,1%000) занимали одинаковые позиции. В возрастных группах 30-39 лет аналогичные показатели варьировались с 1,4%000 до 1,8%000. В возрастных группах 40-49 лет идет рост данных показателей, среди мужского населения они были ниже (4,8%000) по сравнению с показателями среди женщин (5,3%000) и оба пола (5,1%000). Показатели заболеваемости рака прямой кишки среди лиц 50-59 лет варьировались с 15,2%000 до 17,5%000. Заметный рост заболеваемости данной локализации в республике зарегистрирован среди лиц 60-69 лет. У мужского населения - 50,4%000, среди женщин – 32,1%000 (рис.1)

Высокая заболеваемость рака прямой кишки наблюдается среди лиц в возрастных группах 70 лет и старше - 55,5%000 данный показатель среди мужского населения составил 82,1%000, а у женщин 43,0%000.

Повозрастные показатели заболеваемости рака прямой кишки мужского и женского населения республики за период

исследования выросли с увеличением возраста населения. Пик заболеваемости у всего населения в возрастных группах 70 лет и старше, с унимодальным характером роста.

Интенсивные показатели заболеваемости рака прямой кишки населения республики за 10 лет свидетельствуют о том, что в динамике эти показатели имели тенденцию колебания с 7,0‰ (2000г.) до 8,0‰ в 2003 году, в конце исследования данный показатель составил 7,2‰ (рис.2).

Динамика интенсивных и стандартизованных показателей заболеваемости рака прямой кишки мужского населения за изучаемый период имеет тенденцию роста. Период исследования завершился со значением показателя 7,6‰ (рис.3).

Темпы интенсивных и стандартизованных показателей заболеваемости совпадают.

Среди женского населения за 10-летний период отмечается рост показателей с 6,9‰ (2000г.) до 8,0‰ в 2005 году, начиная с 2006 года отмечается снижение до 6,7‰ в конце исследуемого периода (рис.4).

Высокие показатели удельного веса рака прямой кишки всего населения республики (рис.5) по возрастным группам имели неоднородный характер роста. Пик отмечается в возрастных группах 70 лет и старше у женского населения (35,4%), тогда как у мужчин удельный вес в данной возрастной группе составляет 33,4%. Показатель удельного веса в возрастной группе 60-69 лет у мужчин был выше (34,3%) по сравнению с показателем среди лиц 70 лет и старше (33,4%).

Общий среднегодовой интенсивный показатель заболеваемости рака прямой кишки по республике составил $7,3 \pm 0,1$ ‰, стандартизованный (мировой) – $7,3 \pm 0,1$ ‰. Повозрастные показатели заболеваемости рака прямой кишки мужского и женского населения республики за период исследования выросли с увеличением возраста населения. Пик заболеваемости у всего населения в возрастных группах 70 лет и старше, с унимодальным характером роста.

Таким образом, за 10-летний период исследования в республике доля рака прямой кишки в структуре злокачественных опухолей составляет – 4,0 %. Показатели заболеваемости рака прямой кишки за указанный период исследования были в пределах с 7,0‰ (2000г.) до 7,2‰ в конце периода.

Лидирующая позиция заболеваемости рака прямой кишки установлена в г. Алматы (12,4‰). Ряд высоких показателей отмечены в Павлодарской (12,2‰), Костанайской (12,1‰), Северо-Казахстанской (11,6‰) областях.

Наиболее низкими показателями заболеваемости рака прямой кишки отметились Южно-Казахстанская (2,7‰), Кызылординская (2,8‰), Жамбылская (3,2‰) и ряд областей западного региона республики (рис.6).

Изучение динамики заболеваемости рака прямой кишки

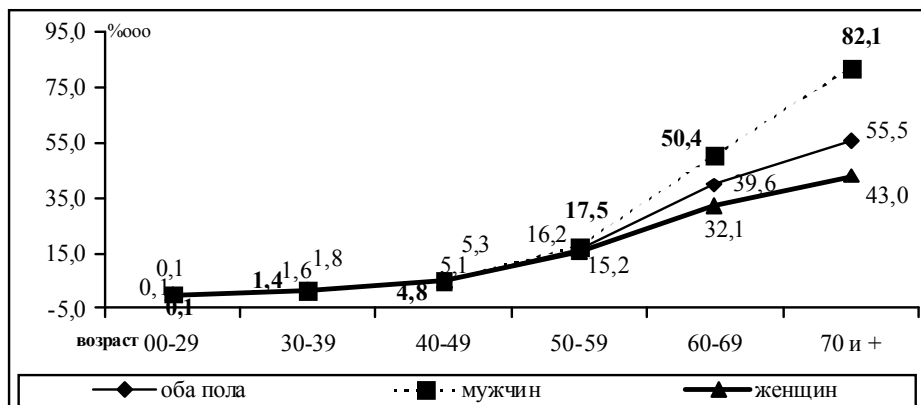


Рисунок 1 - Среднегодовые половозрастные интенсивные показатели заболеваемости рака прямой кишки населения Республики Казахстан за 2000-2009 гг.

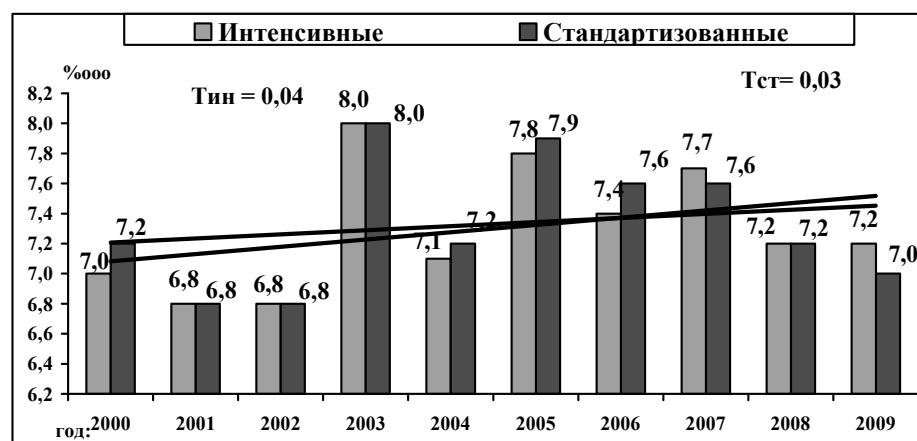


Рисунок 2 – Интенсивные и стандартизованные показатели заболеваемости рака прямой кишки населения Республики Казахстан за 2000-2009гг.

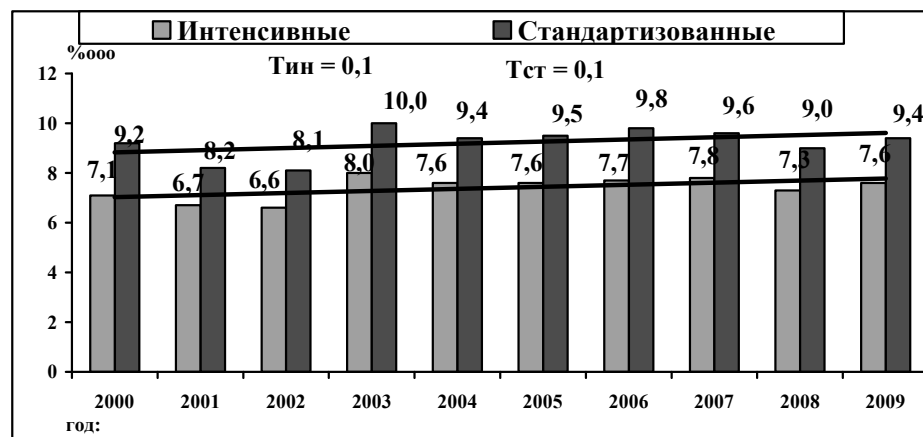


Рисунок 3 – Интенсивные и стандартизованные показатели заболеваемости рака прямой кишки мужского населения Республики Казахстан за 2000-2009гг.

отдельно мужского и женского населения проведено в десятилетних временных и возрастных интервалах.

Возрастные особенности распространения рака прямой кишки в республике характеризуются тем, что в динамике уровень заболеваемости имеет тенденцию к росту в возрастных группах 70 лет и старше, и носит унимодальный характер роста.

Возраст является одним из основных факторов, с которым наиболее отчетливо связано развитие заболевания. При этом зависимость уровня заболеваемости от возраста более выражена по сравнению с другими факторами. Касается это и структуры заболеваемости в различных возрастных группах. Интенсивность роста заболеваемости с возрастом хорошо характеризует индекс отношения возрастного пика заболеваемости к уровню заболеваемости в возрасте 70 лет и старше.

Для адекватного сравнения уровней заболеваемости между поло-возрастными группами, как правило, используются стандартизованные показатели, исключающие влияние на их значения возможных различий в возрастном составе сравниваемых групп населения.

Чрезвычайно важным является изучение распространения заболеваемости во времени. Сопоставление максимального и минимального показателей заболеваемости раком прямой кишки в регионах республики позволяет заключить, что географические, региональные особенности в уровнях заболеваемости могут быть обусловлены различиями в составе населения сравниваемых регионов.

Более углубленные эпидемиологические исследования показывают, что изучение изменений в частоте, структуре и особенностях распространения рака прямой кишки на отдельных территориях республики дает необходимую информацию для планирования лечебно-профилактических мероприятий на государственном и региональном уровнях, способствуя совершенствованию онкологической помощи больным злокачественными новообразованиями прямой кишки.

Таким образом, анализ заболеваемости с учетом возрастного-половых особенностей населения республики за 10 лет (2000-2009гг.) показал, что в динамике рост заболеваемости зависит от возрастного состава населения, т.е. чем старше возраст, тем более пропорционально растет частота рака прямой кишки.

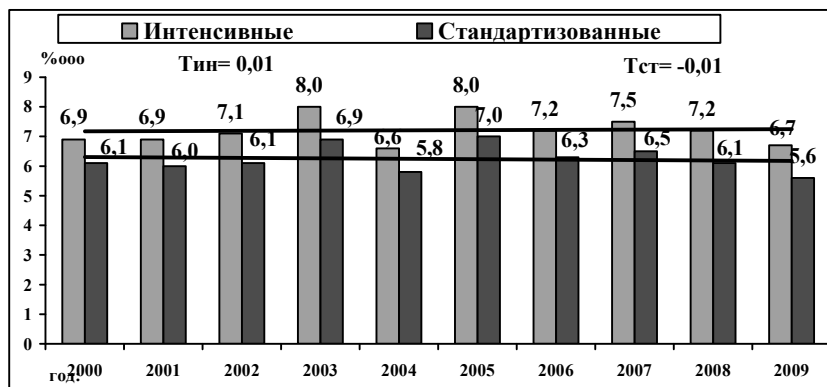


Рисунок 4– Интенсивные и стандартизованные показатели заболеваемости рака прямой кишки женского населения Республики Казахстан за 2000-2009гг.

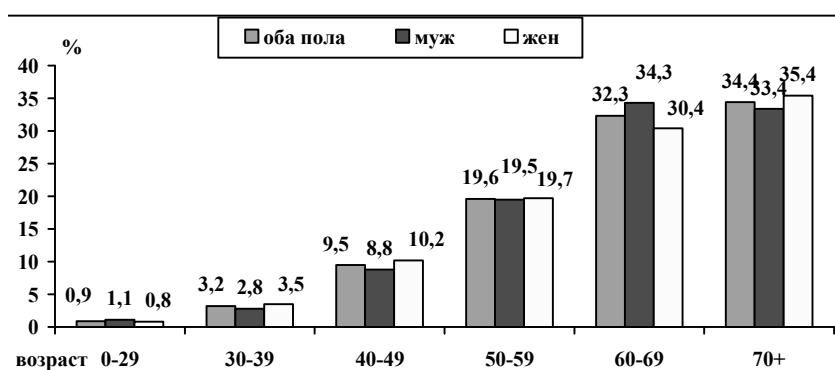


Рисунок 5 – Удельный вес рака прямой кишки по возрастным группам населения Республики Казахстан за 2000-2009гг.

Список использованной

литературы

1. Чиссов В.И., Старинский В.В. *Состояние онкологической помощи населению Российской Федерации.* -М., 2006.
2. Александров В.Б. *Рак прямой кишки.* -М., 2001.
3. Кыш В.И. *Рак ободочной и прямой кишки.* -М., 1997.
4. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д., Игисинов С.И. и др. *Показатели онкологической службы Республики Казахстан (статистические материалы).* -Алматы, 2002.
5. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д., Игисинов С.И. и др. *Показатели онкологической службы Республики Казахстан (статистические материалы).* -Алматы, 2003 – 2010.

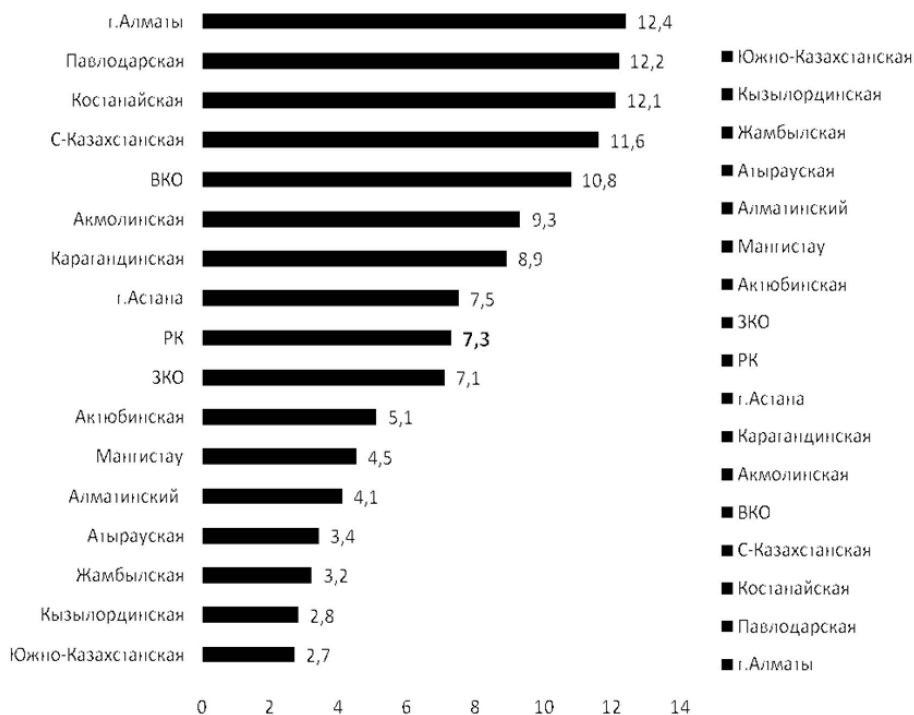


Рисунок 6 - Среднегодовые показатели заболеваемости раком прямой кишки по областям Республики Казахстан за 2000-2009 гг.